جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : تهاني ثروت ناشد عجمي
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الساحل **العنوان :** ---
رقم البطاقة : 27204190103427 **رقم التليفون :** 01202020672 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 19-04-1972 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعة مقطعية مخ مع صبغة [10851] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نهاني ثروت ناشد عجمي
National ID: 27204190103427

GUSTAVE ROUSSY

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من	بشان تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : ---:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of the brain،

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
تهاني
ثروت ناشد عجمي
٦ ش عمر مكرم -حي الزهور
العمرانية - الجيزه
١٩٧٢/٠
٢٧ ٠٣٤ ٠١ ١٩ ٠٤ ٢٧٢
KP1223106


٢٧٢٠٤١٩٠١٠٣٤٢٧ ٢٠٢٤/٠٦
حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب الى
انثى مسيحية متزوجة
هانى حنا شاكر عطاالله
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٥/٣١

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

03/26/2026

MDT FORM

Name:	Tahani Tharwat Nashed Agamy	**MRN:**	9593
Age:	54 Y	**ID:**	27204190103427
Menopausal Sta	post	**Phone:**	01202020627
NRS SCORE:		**Marital Status:**	married
BMI:		**Family History:**	-ve
CO Morbidity:	HTN-Hypothyroid	**Reason Of MDT:**	1st line MBC

Clinical Data:

BX: IDC

ER: 0/8 **PR:** 0/8 **HER2:** 3+ **KI67:**

Sonomammography:

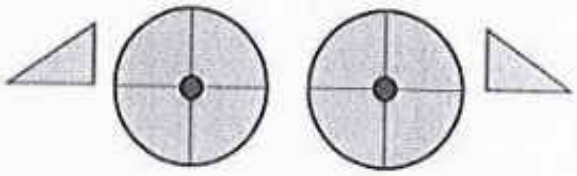
Mets Workup:

History:
Diagnosed case of Lt breast IDC cT3 N3 ER0/8 PR0/8 Her2 3+ in 2024...pt received NACT TCHPx6...Lt MRM in 11/2024 revealing ypT1 N1 disease...PORT & Kadcyla x 12 ending in 8/2025...kept under follow-up....In 12/2025, PET/CT scan revealed brain SOL...pt received WBI 10 sessions on private basis ending 1/2026...and started Tykerb/Xeloda with PR (MRI 3/2026)

Recommendations:
Consider resuming Tykerb/Xeloda

MDT Outcome & Plan
for Tykerb/Xeloda

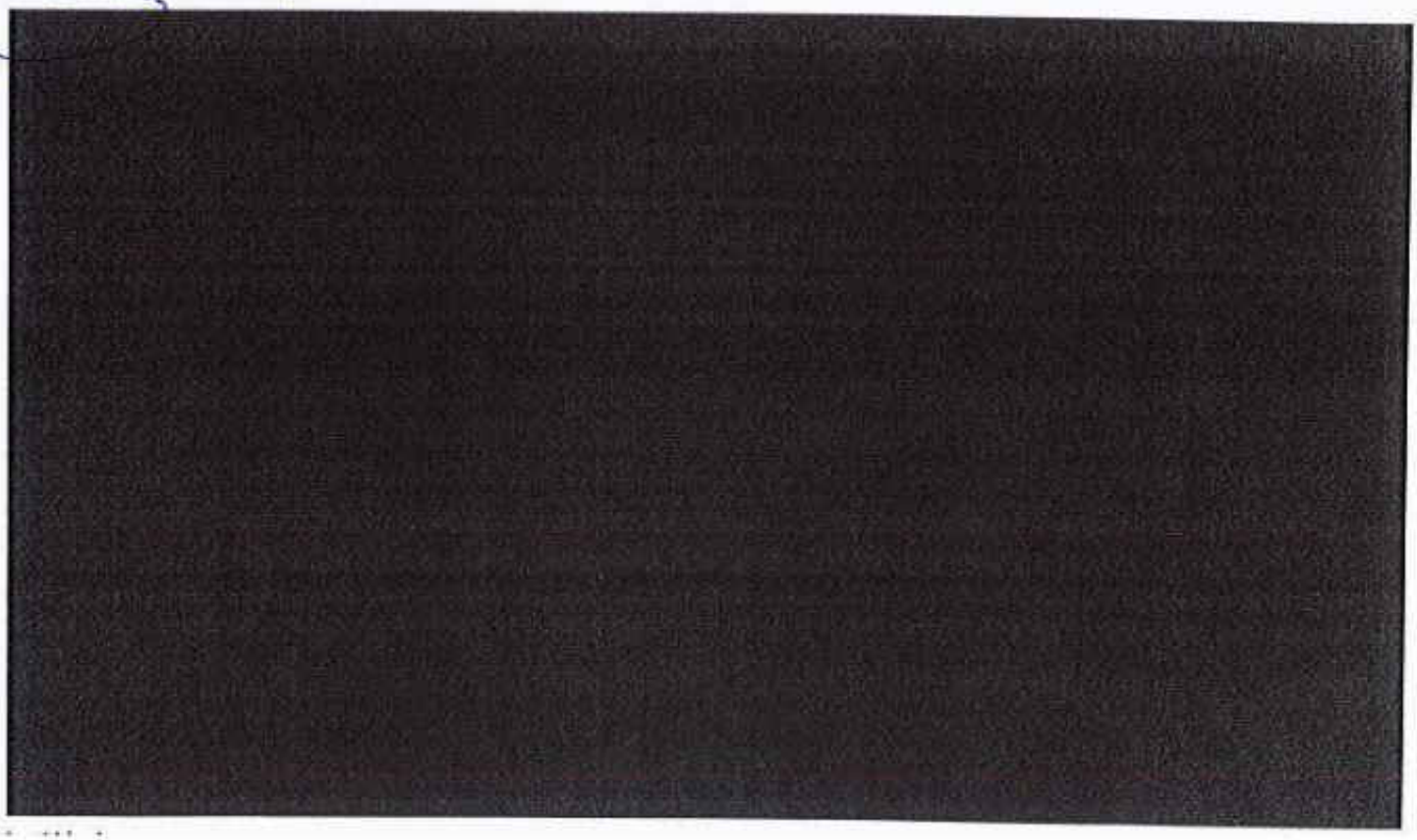
R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ شيماء لاشين د/ نادي حسن	د/ خالد السحري				



Name: نهاني ثروت ناشد عجمي	
MR. : 9593	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 54-year-old individual who is postmenopausal. The clinical history is notable for left breast cancer initially staged as cT3 N3, treated with chemotherapy and trastuzumab on 5/11/2024, followed by left-sided whole-lung irradiation (YPT2 YPN1) and continuation of Kadcyla for 12 cycles, the last dose administered in August 2025. Brain metastases were identified in November 2025, for which the patient received whole-cranial irradiation and was subsequently treated with Xeloda and Tykerb starting in January 2026. A PET-CT performed on 13/7/2026 demonstrated disease progression with mild size regression of a left occipital lesion measuring 2.3 × 1.6 cm and SUV 19.7. Brain MRI on 17/7/2026 showed progression of a left temporal lesion now measuring 1.6 × 2.4 × 2 cm compared with a prior size of 0.2 × 0.9 × 1.5 cm. The patient was recommended stereotactic radiosurgery (SRS) to the left parietal lesion from 15/7 to 1/8 and consideration for a gemcitabine-based regimen with trastuzumab (Herceptin) within an Enhertu trial from the NGO.

The referring team recommended SRS to the left parietal lesion and enrollment in a gemcitabine-trastuzumab trial (Enhertu) through the NGO; however, trastuzumab approval was not obtained from the Ministry of Health. The multidisciplinary team's decision is to continue gemcitabine therapy until approval of Enhertu is secured through the NGO.

تحريرا في ,

التاريخ : 23-09-2026 الوقت :

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / نهاني ثروت حمص	Request No.	: 13004456
Patient No.	: 27204190103427	Request Date	: 05/11/2024
Path No.	: 4271/24	Verification Date	: 12/11/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورنج دايز السلام - تغطية الدولة
Age	: 52 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer post NACT

Nature of the specimen:
Left wide local excision and axillary clearence specimens , collected at 5/11/2024.

Gross Examination:
Three specimens were recieved :
-Left wide local excision specimen measured 9x8.5x2.5 cm with no covering skin ellipse .
• Tumor extent
o Number: An ill defined rubbery to firm greyish white tumor bed site .
o Size: 3.5x2.5x1.5 cm.
o Skin involvement: Free grossly
• Distance from margins: 0.1 cm from least superior margin .
-Axillary clearence specimen : Fibrofatty tissue peice measured 8x4.5x2.5 cm , enclosing 12 nodules up to 2.5x1 cm.
-Extra lateral margin: A fibrofatty tissue piece measured 13.5x9x2 cm with covering skin ellipse measured 8x2.5 cm, it showed gross indurations.
• Frozen section:
-Lateral and superficial margins are involved by DCIS.
-Extra lateral margin is involved by DCIS and suspicious for invasive carcinoma.
-Free other margins.

Microscopic examination:
• Histological type: Residual Invasive duct carcinoma.
• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1).
-Tumor cellularity:10% (0.2 cm in maximal dimension).
• Angioinvasion: No.
• Ductal carcinoma in situ:Focal (9%).

Verified by :
DR.Monna Nabil

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

CamScanner

Patient Name	: الأستاذة / الهام ثروت حمص	Request No.	: 13004456
Patient No.	: 27204190103427	Request Date	: 05/11/2024
Path No.	: 4271/24	Verification Date	: 12/11/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام ثدي السلام - تغطية الدولة
Age	: 52 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

- Lymph node involvement: Positive (3/12).
- Resection Margins: Free all resected margins
- Histological responce to therapy: Pathologic partial responce.

Diagnosis:
Left breast cancer post NACT, wide local excision and axillary clearence specimens:
-Residual invasive duct carcinoma GII with focal DCIS.
Maximal invasive tumour diameter 0.2 cm.
-Tumor cellularity: 1%.
-Resection margins:
Extra lateral margin showed DCIS. Free of invasive tumour.
Free other resected margins.
-Lymph nodes :Positive (3/12).
-Pathologic partial responce.
-Stage : ypT1a , ypN1.
- Residual cancer burden: 2.414, RCB class II.

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Nermin Muhammed

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr FIQadema - Cairo, Egypt

CamScanner

alfa SCAN

٩٠٩٣

Name: Tahany Tharwat Nashed *ID: 3370768*
Referred by: Prof. Wael Samir Makkar *Date: 15/12/2025*

^{18}F-FDG PET/CT examination

Clinical Indication:

- *Patient with history of right cerebellar lesion, and left breast cancer, underwent left mastectomy followed by chemoradiotherapy and hormonal therapy, for assessment of response.*

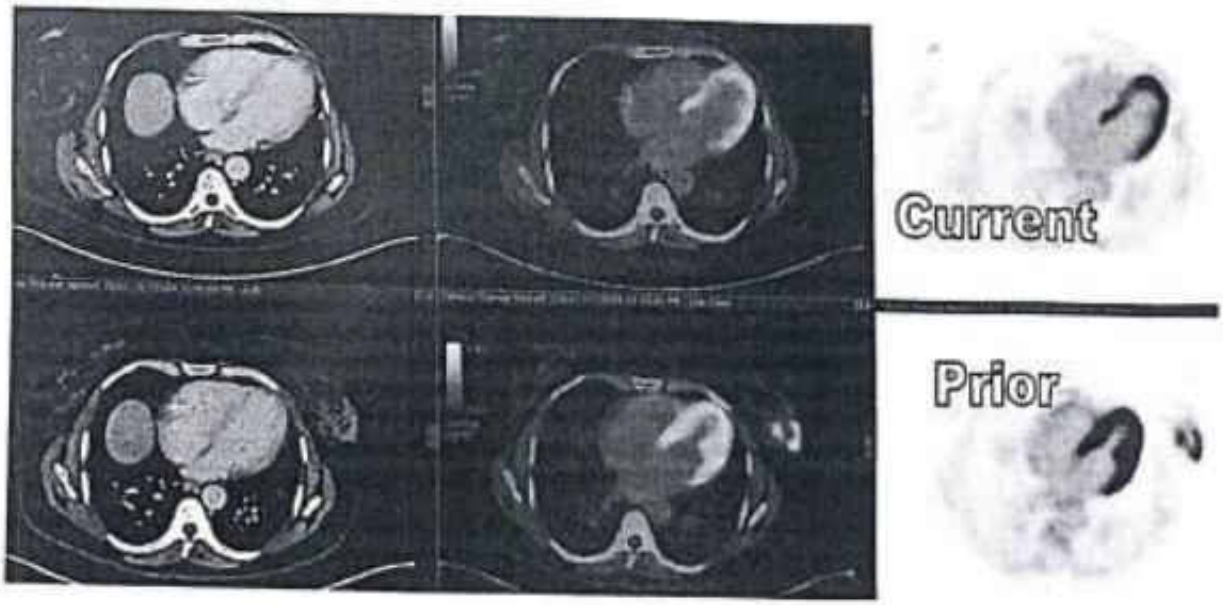
Administered activity: 329 MBq. ^{18}F-FDG **B.G.L.** : 118 mg/dL

Examination protocol:

- **A Whole body PET/CT study was obtained from skull vertex to the mid-thigh using a low dose non contrast CT for attenuation correction**
- **Diagnostic multislice CT examination after IV contrast administration of the same region.**

Comparison was made to the FDG PET/CT study dated 07/05/2024

I. ***PET/CT Findings:***



CamScanner

alfa
SCAN

Name: Tahany Tharwat Nashed	*ID: 3370768*
Referred by: Prof. Wael Samir Makkar	*Date: 15/12/2025*

^{18}F-FDG PET/CT examination

Clinical Indication:

- *Patient with history of right cerebellar lesion, and left breast cancer, underwent left mastectomy followed by chemoradiotherapy and hormonal therapy, for assessment of response.*

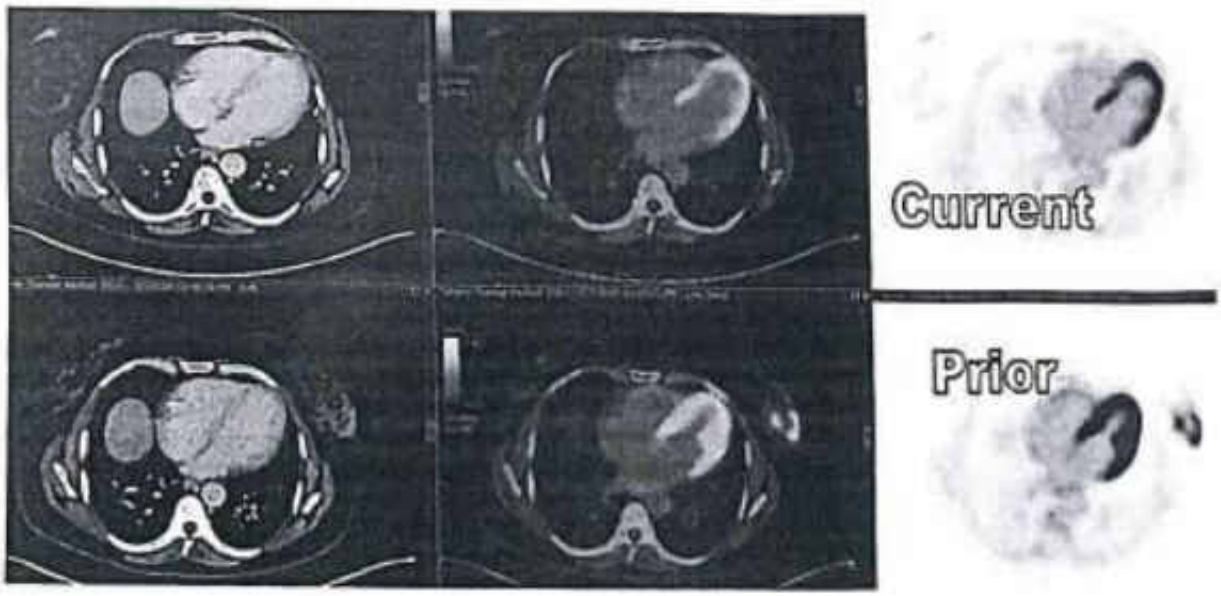
Administered activity: 329 MBq. ^{18}F-FDG **B.G.L.** : 118 mg/dL

Examination protocol:

- **A Whole body PET/CT study was obtained from skull vertex to the mid-thigh using a low dose non contrast CT for attenuation correction**
- **Diagnostic multislice CT examination after IV contrast administration of the same region.**

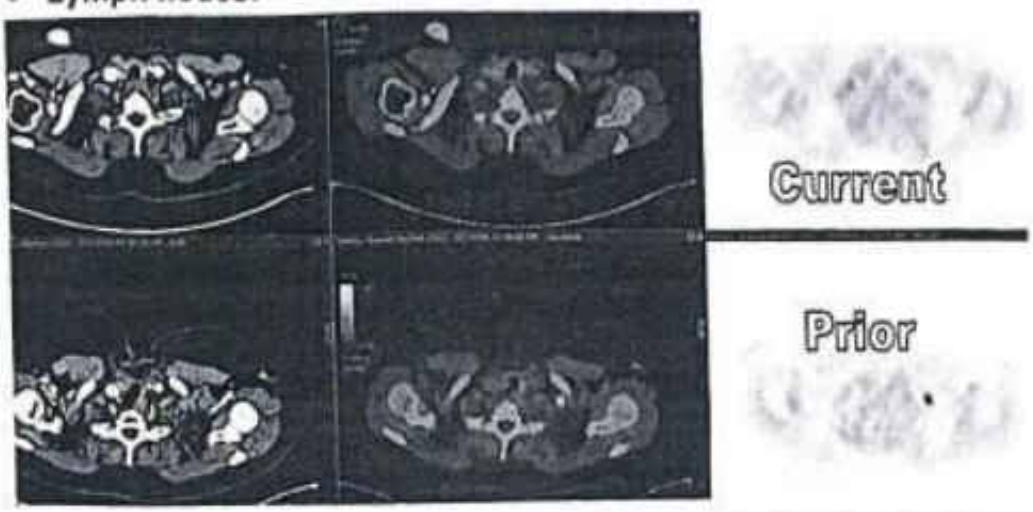
Comparison was made to the FDG PET/CT study dated 07/05/2024

I. ***PET/CT Findings:***



CamScanner

- **Interval left mastectomy and axillary dissection bed with low grade FDG uptake within soft tissue thickening, likely post-operative sequelae. No FDG avid lesions.**
- **Lymph nodes:**

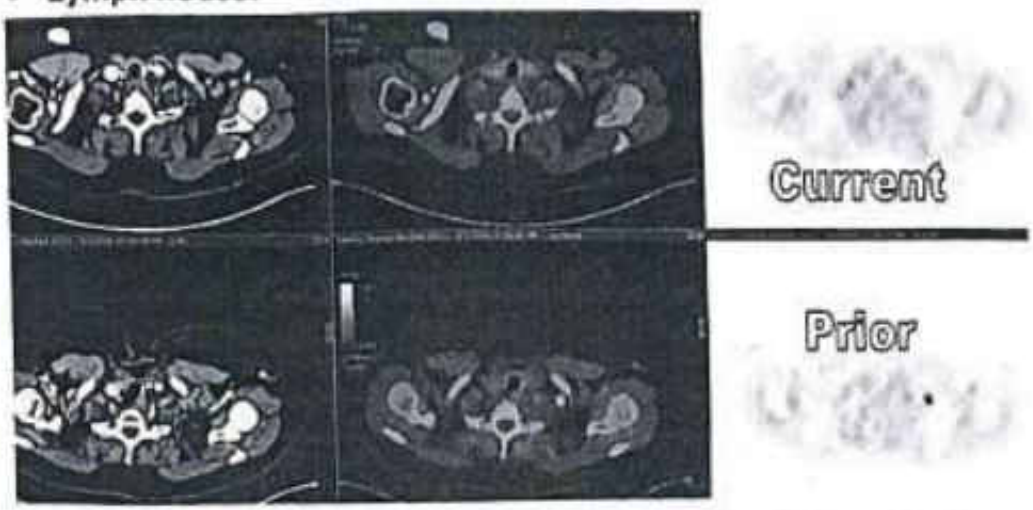


  - **Almost metabolic resolution of the previously described:**
    - **Cervical,** left infraclavicular lymph node.
    - **Mediastinal,** left internal mammary lymph node.
  - No newly developed FDG avid or pathologically enlarged lymph nodes.
- **Brain:**
  - **Newly developed marginally enhancing FDG avid left occipital lesion** with SUVmax 12.2 and measures 3.3x 1.6 cm associated with hypometabolism of adjacent parenchyma related to vasogenic edema and effacement of adjacent sulci.

CamScanner

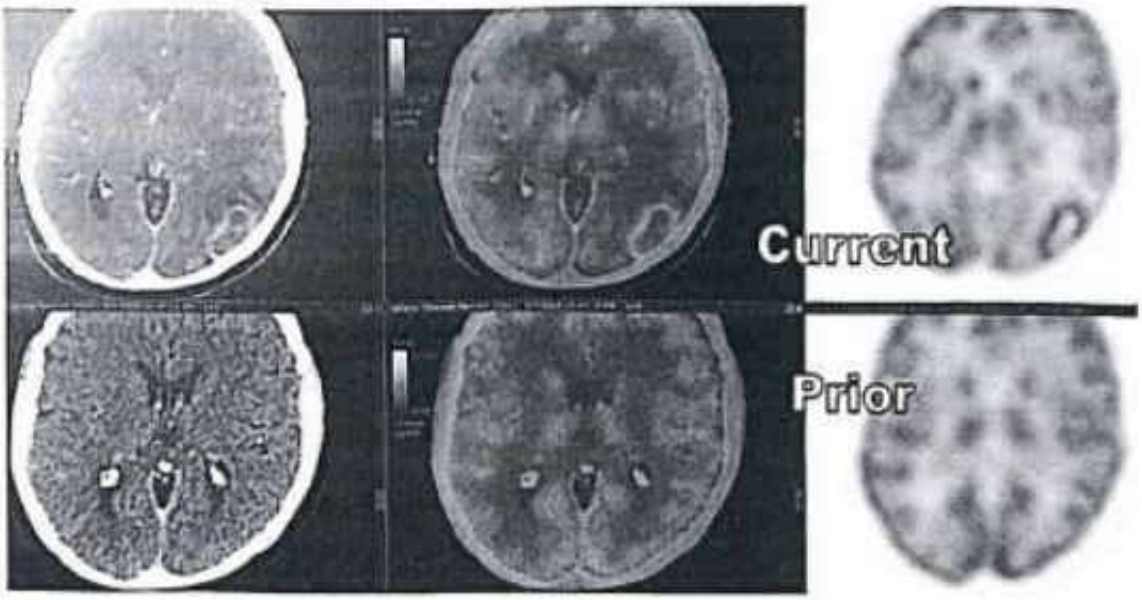
alfa
SCAN

- Interval left mastectomy and axillary dissection bed with low grade FDG uptake within soft tissue thickening, likely post-operative sequelae. No FDG avid lesions.
- Lymph nodes:



  - Almost metabolic resolution of the previously described:
    - **Cervical**, left infraclavicular lymph node.
    - **Mediastinal**, left internal mammary lymph node.
  - No newly developed FDG avid or pathologically enlarged lymph nodes.
- Brain:
  - **Newly developed marginally enhancing FDG avid left occipital lesion** with SUVmax 12.2 and measures 3.3x 1.6 cm associated with hypometabolism of adjacent parenchyma related to vasogenic edema and effacement of adjacent sulci.

CamScanner

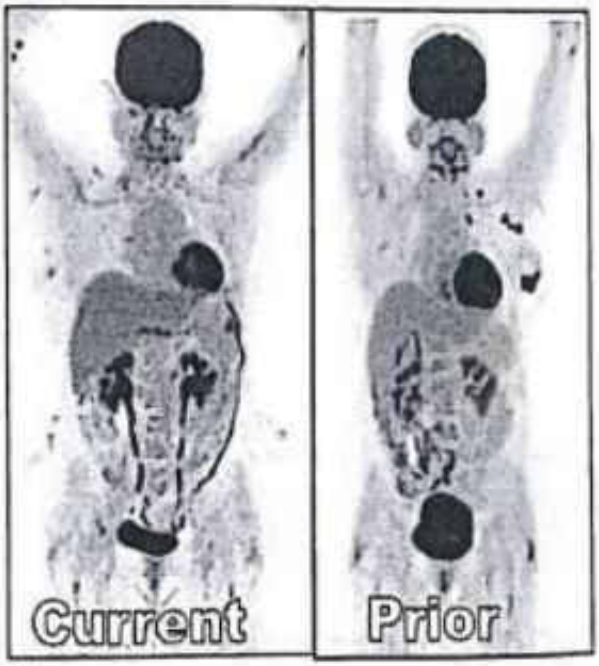


- Resolution of the previously noted FDG activity within hyperdense hemorrhagic lesion in the medial aspect of the right cerebellum.

- **Right breast,** no FDG avid lesions.
- **Thyroidectomy operative bed,** no FDG avid lesions.
- **Lungs:**
  - Still noted few tiny bilateral pulmonary nodules with no significant FDG uptake.
  - Still noted non-FDG avid calcified middle lobe granuloma.
  - **Currently noted** low grade FDG uptake within left peripheral atelectatic changes, ***post-radiation sequelae.***
- **Liver:**
  - Average sized, with no FDG avid focal lesions. No dilated biliary radicles. Patent main portal vein.
  - Still noted non-FDG avid hypodense segment II lesion, measures about 1.2 cm, ***likely cyst.***

alfa
SCAN

- **Spleen,** no FDG avid focal lesions.
- **Pancreas,** no FDG avid focal lesions.
- No FDG avid lesions or abnormal mural thickening seen within **small or large bowel.**
- **Stomach,** no FDG avid lesions.
- **Pelvis:** No FDG avid lesions.
- **Bone marrow,** no FDG avid focal lesions.
- FDG activity related to bilateral gluteal injection sites.



II. Diagnostic CT Findings:

- No pleural, pericardial or peritoneal collections.
- The adrenals, kidneys (left renal cyst), aorta and IVC appear unremarkable.
- Right port-catheter.

OPINION:

Follow up study after interval left mastectomy and axillary dissection demonstrates:

- **Low grade metabolically active soft tissue thickening within left mastectomy and axillary dissection bed, post-operative changes.**
- **Newly developed metabolically active left occipital brain lesion as described likely metastatic for MRI.**

Radiologist
Dr. Mohamed Hosony, MD

Nuclear Medicine Physicians
Dr. Sherif El-Refael, MD, EBNM
Dr. Maha Khalil, MD

CamScanner

MASSARRA Scan

Pat. Name Mrs. Tahany Tharwat Nashed Agamy	Pat. ID: 180937
Ref. Doctor: د/وائل سمير	Date : 10/03/2026

REPORT

POST-CONTRAST MRI EXAMINATION OF THE BRAIN REVEALED

Technique:-

- Axial T1,T2 and FLAIR WIs
- Coronal T2 WIs
- Post-contrast scans

Findings:-

Known case of breast cancer.

Compared to the lat available study dated 29/12/2025 the current study revealed:

- Further regressive course of the previously noted left temporo-occipital fairly defined cortical and subcortical space occupying lesion, it's currently measuring 2.x9x15mm in its maximum AP, TS and CC dimension as compared to 36x22x25mm at the previous study. It elicits intermediate to low T1 signal, heterogenous bright T2 / FLAIR signal with evidence of irregular marginal post contrast enhancement as well as non enhancing central area of necrosis / cystic degeneration.
- Also regressive course of the surrounding vasogenic edema (only noted at the occipital lobe in today's study).
- The forenoted lesion and the surrounding oedema exert mild mass effect in form of effacement of the overlying cortical sulci.
- No significant mass effect on the left lateral ventricle in today's study.
- No newly developed lesions.
- Capacious both lateral ventricles.

Pat. Name Mrs. Tahany Tharwat Nashed Agamy	Pat. ID: 180937
Ref. Doctor: د/ وائل سمير	Date : 10/03/2026

- Bilateral fronto-parietal subcortical few subacute lacunar infarcts are noted.
- No midline shift.
- Normal posterior fossa structures.
- No definite calvarial or skull base osseous lesions are noted.

Side finding:-

- Left maxillary sinusitis.

Conclusion:

- Known case of left temporo-occipital metastatic brain lesion showing regressive course regards its size and the surrounding edema as described.
- No newly developed lesions.

Best regards,

Dr. Ramy Edward Asaad, MD

Dr. Trez Ayad.MSc

مركز الجيزة الأشعة
GIZA SCAN

أ.د/ حســـــن الكيكى
أ.د/ محمد عبد اللطيف
د./ رانـــيـــا حـــمدى
د./ أيمـــن عبد الوهاب

NAME: تهانى ثروت ناشد عجمى	ID: 1985528
Prof. Dr: وائل سمير مقار	DATE 30/12/2025

MRI EXAMINATION OF THE BRAIN

Technique of examination:

- Axial T1, T2 & Flair WIs
- Sagittal T1 and Coronal T2 WIs.
- IV contrast was given .

MRI Findings:

Known case of breast cancer compared to previous MRI dated 16-11-2025:

- The known well defined , dural-based space occupying lesion at the left occipito-temporal region has reduced marignally in size now measuring 28x16x24mm compared to 36x22x25 mm at maximum axial and CC dimensions in the comparative study.
- The lesion still shows peripheral enhancement and central necrosis with surrounding vasogenic edema – although the edema has decreased to some extent. Still noted some mass effect on the left lateral ventricle.
- No new extra or intra axial lesions.
- No midline shift or transtentroial herniation.
- Otherwise, normal size shape & position of the cerebral ventricles.
- No gross vascular abnormality.
- Normal cerebellum, brain stem & cervico – medullary junction.
- Normal sellar region.
- Normal extra axial spaces.

Opinion:

- ***Mild reduction in the size of the dural metastatic lesion as well as the surrounding edema.***
- ***No newly developed lesions.***

Best regards;

Prof. Hassan Elkiki **Dr. Khaled Adel, FRCR**

٥ ش مراد - ميدان الجيزة تليفاكس : ٣٧٧٤٦٠٣٠ - ٣٧٧٤٦٠٣١ - ٢٥٦٨٨٩٥٤ موبايل: ٠١١٤٠٧٧٢٦٨
E-mail:giza.scan@yahoo.com

مركز الجيزة للأشعة
GIZA SCAN

أ.د/ حســـــن الكيكى
أ.د/ محمد عبد اللطيف
د./ رانـــيـــا حـــمدى
د./ أيمـــن عبد الوهاب

Name: تهاني ثروت ناشد عجمي	ID: 1985528
Prof Dr : Mohamed Ibrahim Orabi	Date 16/11/2025

MRI EXAMINATION OF THE BRAIN

Technique of examination:

- Axial T1, T2 & Flair WIs
- Sagittal T1 and Coronal T2 WIs.
- IV contrast was given .

MRI Findings:

Known case of breast cancer showing:

- There is a well defined , dural-based space occupying lesion at the left occipito-temporal region measuring about 3.6x2.2x2.5 cm at maximum axial and CC dimensions.
- It exhibits heterogeneous low T1 and high T2/FLAIR signal. It minor foci of internal low signal on SWI images. No internal diffusion restriction noted.
- It is seen associated with extensive vasogenic edema and mass effect in the form of effacement of the related sulci and compression of the ipsilateral ventricle.
- **The post-contrast images revealed heterogeneous enhancement**
- No midline shift or transtentroial herniation.
- Otherwise, normal size shape & position of the cerebral ventricles.
- No gross vascular abnormality.
- Normal cerebellum, brain stem & cervico – medullary junction.
- Normal sellar region.
- Normal extra axial spaces.

Opinion:

- ***Intra-cranial left occipito-temporal dural-based neoplastic mass lesion with heterogeneous enhancement suggesting metastatic nature .***

Best Regards;
Prof. Hassan Elkiki
Dr. Nourhan El-Shrief Msc.

٥ ش مراد - ميدان الجيزة تليفاكس : ٢٧٧٤٦٠٢٠ - ٢٧٧٤٦٠٣١ - ٢٥٦٨٨٩٥٤ موبايل: ٠١١٤٠٧٧٢٢٦٨
E-mail:giza.scan@yahoo.com

جوستاف روسي
انترناشونال

إسم المريض ثلاثي: .....
رقم الملف: .....

تقريـر طبـي

السيد/.....

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من ..... بشان تقرير طبي للمريض:.....

بقسم.....رقم طبي .....

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول.....تاريخ وساعة الخروج.....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تحريرا في

الوقت: ..... **التاريخ :** ٢٠٢٦/٢/٢

الطبيب المعالج

.....

يعتمد ،،

Scan
MASSARRA

Pat. Name: Tahany Tharwat Nashed Agamy	Pat. ID: 180937
Ref. Doctor: وائل مقار	Date : 20/09/2026

POST-CONTRAST MRI EXAMINATION OF THE BRAIN REVEALED

Technique:-

- Axial T1,T2 and FLAIR WIs
- Coronal T2 WIs
- Post-contrast scans

Findings:-

Known case of breast cancer.

Compared to the last available study dated 17/7/2026 the current study revealed:

- Minimalregressive course of the previously noted left temporo-occipital fairly defined cortical and subcortical space occupying lesion, it's currently measuring 1.3 x 2.3 x 1.9 cm in its maximum AP, TS and CC dimension as compared to 1.6 x 2.4 x 2 cm at the previous study. It elicits intermediate to low T1 signal, heterogenous bright T2 / FLAIR signal with evidence of irregular post contrast enhancement as well as non enhancing central area of necrosis / cystic degeneration.
- Still noted moderate amount of surrounding vasogenic edema (still noted at the occipital lobe in today's study).
- The forenoted lesion and the surrounding edema exert mild mass effect in form of effacement of the overlying cortical sulci.
- No newly developed lesions.
- Mildly dilated both lateral ventricles.
- Bilateral fronto-parietal subcortical few subacute lacunar infarcts are noted.
- No midline shift.
- Normal posterior fossa structures.
- No definite calvarial or skull base osseous lesions are noted.

Conclusion:

- **Known case of left temporo-occipital metastatic brain lesion showing minimal regressive course regards its size with rather stationary course of the surrounding edema as described.**
- **No newly developed lesions.**

Best Regards,

Dr. George Ayad M.D

مركز مسرة سكان للأشعة التشخيصية
٩ شارع مسرة - روض الفرج - القاهرة - تليفون: ٢٤١٦٢٠٢٤٢ - ٢٤٦٢٠٢٤٢ - ٠١٢٧١٧٠٢٨٢٩
URL : www.massarrascan.com E-Mail: info@massarrascan.com

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



تهانى
ثروت ناشد عجمى
٦ ش عمر مكرم -حى الزهور
العمرانية - الجيزه

١٩٧٢/٠٤/١٩

٢٧ ٠٣٤ ٠١ ١٩ ٠٤ ٢٧٢

KP1223106



٢٧٢٠٤١٩٠١٠٣٤٢٧ ٢٠٢٤/٠٦
حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلى

أنثى مسيحية متزوجة
هانى حنا شاكر عطاالله
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٥/٣١ ١

جوستافا روسي

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

09/08/2026

MDT FORM

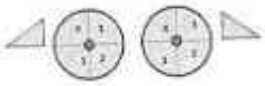
Name:	Tahani Tharwat Nashed Agamy	**MRN:**	9593
Age:	54 Y	**ID:**	27204190103427
Menopausal Sta	postm	**Phone:***	01222332820
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
Gender		**Reason Of MDT:**	last mdt for gemzar herceptin no approval of herceptin
CO Morbidity:			
Surgical History:*	left wle	**ECOG Performance Status**	○ 0 ○ 1 ○ 2 ◉ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX:

ER: **PR:** **HER2:** **KI67:**

R L



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

History:
postmleft metastatic breast cancer to brain er-ve pr-ve her23+ .
history
left breast cancer ct3 n3 mo rec tchp on 5/11/2024 left wle ypt2 ypn1 rec
port kadcyla x12 last 8/2025
11/2025 brain mets rec wci str xeloda tykerb from 1/2026
pet ct On 13/7/2026; met progression with mild size regression left occipital 2.3x1.6 suv 19.7
mri brain on 17/7/2026 mri progression of left temoral sol m 1.6x2.4x2 comp to 0.2x0.9x1.5
pt rec srs to left parietal lesion from 15/7 to 1/8 mdt for gemzar herceptin
trial of enhertu from ngo
pt st gemzar singler agent c1 d1 5/9
but no approval of herceptin at MOH

Clinical Staging:

Pathological Staging:

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan
Continue On gemcitabine till approval of Enhertu in NGO

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. خالد عبد العزيز			

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient name:

MRN: 9593

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 5../9../24	Time of delivery: 5..:..	Transfusion start time: 6:30	End Time: 8:30	
Blood Group & RH Type: (B+)	Type of blood unit: (B+)	Blood unit No: 2..704		

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: Mennasaid 3059 Signature: Mennasaid	☐ Charge Nurse	Name & ID: Azza Said 3012 Signature:	
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: Mennasaid 3059 Signature: Mennasaid	☐ Charge Nurse	Name & ID: Azza Said 3012 Signature:	

Nursing Observation: ☑ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)

If reaction, Notified to: .....Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	6.30	36.5	85	100	16	105/73	0
After 5 minutes	6.35	36.7	86	100	16	110/75	0
After 10 minutes	6.40	36.6	88	99	17	117/80	0
After 15 minutes	6.45	36.6	87	99	18	122/83	0
After 30 minutes	7	36.8	90	98	18	125/84	0
After 45 minutes	7.15	36.8	92	98	17	130/85	0
After 60 minutes	7.30	36.7	93	100	20	132/87	0
After 90 minutes	8	37	95	99	19	130/85	0
After completion of transfusion	8.30	36.7	95	98	18	128/82	0
After 5 minutes from completion of transfusion	8.35	36.7	92	99	18	126/83	0
After 1 hour from completion of transfusion	9.30	37	93	99	17	125/84	0
After 2 hours from completion of transfusion	10.30	36.5	94	100	18	126/86	0

Nurse Name & ID: Mennasaid 3059 Signature: Mennasaid Date: 5../9../24 Time: 10:..:10

* Use separate form for each unit transfused.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

DOCTOR'S ORDERS

الرقم الطبي:	9583
اسم المريض:	نهاني نروت ناشد عجمي
تاريخ الميلاد:	19/04/1972
الرقم الطبي القديم:	1547/2024

Diagnosis: B Unit: day care Diet Type: Normal diet

Date	Time Of Order	Doctor's Order	Physician Name & ID	Signature	Nurse Name & ID	Signature	Time of Order Execution
					Mahra said 3089	Mahra Said	
							6.30

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
* Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

الرقم الطبي:	9593
اسم المريض:	نهاني نبروه ناشد عجمي
تاريخ الميلاد:	19/04/1972
الرقم الطبي القديم:	1547/2024

Blood /Blood Components Transfusion Co...

اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

اقر انا الموقع ادناه (المريض/ ممثل القانوني)..... رقم قومي / جواز سفر.....

الرقم الطبي : ..... التشخيص: .....

أني قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته و ذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح و مفهوم:

١-سبب الحاجة الى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبًا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبًا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتهابات أو فشل الكبد.

٢-الفوائد المتوقعة من هذا الاجراء

٣-المخاطر و المضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ-ردود الفعل التحسسيةو التي قد تشمل قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب-ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بامراض فيروسية و بكتيرية.

د-مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ-حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم ان وجدت.

٥- حقي في طرح الأسئلة و الحصول على الاجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

اقر انا المقع ادناه باني على كامل المعرفة و الفهم لكل مشتملات هذا الاقرار و اتحمل المسؤلية كاملة عن كل ما فيه

أسم المريض (او ممثله القانوني): ..... اسم الطبيب المعالج/ الرقم الوظيفي: .....

درجة القرابة: ..... التوقيع: .....

رقم قومي / جواز سفر: ..... التاريخ/ الوقت: .....

التوقيع: .....

اسم الشاهد: .....

التاريخ/ الوقت: .....

رقم قومي / جواز سفر: .....

التوقيع: .....

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no:	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age:
Diagnosis:		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion:	☐ No ☐ Yes	
History of Previous Blood Transfusion Reaction:	☐ No ☐ Yes, specify.....	

Number of Units Needed:	**To be delivered to:**
☐ Whole Blood..... Units ☐ Packed Cells..... Units ☐ Platelets.....Units ☐ F.F.P..... Units ☐ Cryoprecipitate..... Units ☐ Auto transfusion..... Units ☐ Other: ..... Units	☐ OR ☐ ED ☐ ICU ☐ BMT
Urgency: ☐ **Immediate**: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ **Urgent**: Cross matching tests take **1 hour** ☐ **Routine**: compatibility test take two hours	**Frequency of Transfusion:**

Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date:	Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date:	Time

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

2567	تهاني ثروت نافد
MRN:	1547/24
	نفقة دولة نقدى

Blood Delivery form

	Components	Amount		Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐	Scheduled	
☐	Packed RBCs	One Unit	☐	Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐	High Emergency (withou tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs		☐		
☐	Fresh Frozen Plasma		☐		
☐	Platelet concentrate		☐		
☐	Cryo precipitate		☐		
☐	Irradiated Platelet		☐		

Time of Delivery of Blood Components: 6:25:26 م

Blood Group: (B) RH Group (D antigen): Positive

Antibody Screening: ----------

Cross Matching: Matched

Bag No.:

2724	23944933		
Donation time	EXPIRATION DATE	Donation time	EXPIRATION DATE
25/8/2026	29/9/2026		

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	5-2026-سبتمبر	6:25 م

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
		5-2026-سبتمبر	6:25 م

جوستاف روسي
انترناشونال

إسم المريض ثلاثي: .....
رقم الملف: .....

تقريـر طبـي

السيد/.....

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من ..... بشان تقرير طبي للمريض:.....

بقسم.....رقم طبي .....

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول.....تاريخ وساعة الخروج.....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تحريرا في

الوقت: ..... **التاريخ :** ٢٠٢٦/٢/٢

الطبيب المعالج

.....

يعتمد ،،

Scan
MASSARRA

Pat. Name: Tahany Tharwat Nashed Agamy	Pat. ID: 180937
Ref. Doctor: وائل مقار	Date : 20/09/2026

POST-CONTRAST MRI EXAMINATION OF THE BRAIN REVEALED

Technique:-

- Axial T1,T2 and FLAIR WIs
- Coronal T2 WIs
- Post-contrast scans

Findings:-

Known case of breast cancer.

Compared to the last available study dated 17/7/2026 the current study revealed:

- Minimalregressive course of the previously noted left temporo-occipital fairly defined cortical and subcortical space occupying lesion, it's currently measuring 1.3 x 2.3 x 1.9 cm in its maximum AP, TS and CC dimension as compared to 1.6 x 2.4 x 2 cm at the previous study. It elicits intermediate to low T1 signal, heterogenous bright T2 / FLAIR signal with evidence of irregular post contrast enhancement as well as non enhancing central area of necrosis / cystic degeneration.
- Still noted moderate amount of surrounding vasogenic edema (still noted at the occipital lobe in today's study).
- The forenoted lesion and the surrounding edema exert mild mass effect in form of effacement of the overlying cortical sulci.
- No newly developed lesions.
- Mildly dilated both lateral ventricles.
- Bilateral fronto-parietal subcortical few subacute lacunar infarcts are noted.
- No midline shift.
- Normal posterior fossa structures.
- No definite calvarial or skull base osseous lesions are noted.

Conclusion:

- **Known case of left temporo-occipital metastatic brain lesion showing minimal regressive course regards its size with rather stationary course of the surrounding edema as described.**
- **No newly developed lesions.**

Best Regards,

Dr. George Ayad M.D

مركز مسرة سكان للأشعة التشخيصية
٩ شارع مسرة - روض الفرج - القاهرة - تليفون: ٢٤١٦٢٠٢٤٢ - ٢٤٦٢٠٢٤٢ - ٠١٢٧١٧٠٢٨٢٩
URL : www.massarrascan.com E-Mail: info@massarrascan.com

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



تهانى
ثروت ناشد عجمى
٦ ش عمر مكرم -حى الزهور
العمرانية - الجيزه

١٩٧٢/٠٤/١٩

٢٧ ٠٣٤ ٠١ ١٩ ٠٤ ٢٧٢

KP1223106



٢٧٢٠٤١٩٠١٠٣٤٢٧ ٢٠٢٤/٠٦
حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلى

أنثى مسيحية متزوجة
هانى حنا شاكر عطاالله
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٥/٣١ ١

جوستافا روسي

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

09/08/2026

MDT FORM

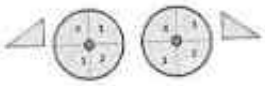
Name:	Tahani Tharwat Nashed Agamy	**MRN:**	9593
Age:	54 Y	**ID:**	27204190103427
Menopausal Sta	postm	**Phone:***	01222332820
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
Gender		**Reason Of MDT:**	last mdt for gemzar herceptin no approval of herceptin
CO Morbidity:			
Surgical History:*	left wle	**ECOG Performance Status**	○ 0 ○ 1 ○ 2 ◉ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX:

ER: **PR:** **HER2:** **KI67:**

R L



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

History:
postmleft metastatic breast cancer to brain er-ve pr-ve her23+ .
history
left breast cancer ct3 n3 mo rec tchp on 5/11/2024 left wle ypt2 ypn1 rec
port kadcyla x12 last 8/2025
11/2025 brain mets rec wci str xeloda tykerb from 1/2026
pet ct On 13/7/2026; met progression with mild size regression left occipital 2.3x1.6 suv 19.7
mri brain on 17/7/2026 mri progression of left temoral sol m 1.6x2.4x2 comp to 0.2x0.9x1.5
pt rec srs to left parietal lesion from 15/7 to 1/8 mdt for gemzar herceptin
trial of enhertu from ngo
pt st gemzar singler agent c1 d1 5/9
but no approval of herceptin at MOH

Clinical Staging:

Pathological Staging:

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan
Continue On gemcitabine till approval of Enhertu in NGO

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. خالد عبد العزيز			

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient name:

MRN: 9593

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 5../9../24	Time of delivery: 5..:..	Transfusion start time: 6:30	End Time: 8:30	
Blood Group & RH Type: (B+)	Type of blood unit: (B+)	Blood unit No: 2..704		

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: Mennasaid 3059 Signature: Mennasaid	☐ Charge Nurse	Name & ID: Azza Said 3012 Signature:	
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: Mennasaid 3059 Signature: Mennasaid	☐ Charge Nurse	Name & ID: Azza Said 3012 Signature:	

Nursing Observation: ☑ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)

If reaction, Notified to: .....Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	6.30	36.5	85	100	16	105/73	0
After 5 minutes	6.35	36.7	86	100	16	110/75	0
After 10 minutes	6.40	36.6	88	99	17	117/80	0
After 15 minutes	6.45	36.6	87	99	18	122/83	0
After 30 minutes	7	36.8	90	98	18	125/84	0
After 45 minutes	7.15	36.8	92	98	17	130/85	0
After 60 minutes	7.30	36.7	93	100	20	132/87	0
After 90 minutes	8	37	95	99	19	130/85	0
After completion of transfusion	8.30	36.7	95	98	18	128/82	0
After 5 minutes from completion of transfusion	8.35	36.7	92	99	18	126/83	0
After 1 hour from completion of transfusion	9.30	37	93	99	17	125/84	0
After 2 hours from completion of transfusion	10.30	36.5	94	100	18	126/86	0

Nurse Name & ID: Mennasaid 3059 Signature: Mennasaid Date: 5../9../24 Time: 10:..:10

* Use separate form for each unit transfused.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

DOCTOR'S ORDERS

الرقم الطبي:	9583
اسم المريض:	نهاني نروت ناشد عجمي
تاريخ الميلاد:	19/04/1972
الرقم الطبي القديم:	1547/2024

Diagnosis: B Unit: day care Diet Type: Normal diet

Date	Time Of Order	Doctor's Order	Physician Name & ID	Signature	Nurse Name & ID	Signature	Time of Order Execution
					Mahra said 3089	Mahra Said	
							6.30

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
* Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

الرقم الطبي:	9593
اسم المريض:	نهاني نبروه ناشد عجمي
تاريخ الميلاد:	19/04/1972
الرقم الطبي القديم:	1547/2024

Blood /Blood Components Transfusion Co...

اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

اقر انا الموقع ادناه (المريض/ ممثل القانوني)..... رقم قومي / جواز سفر.....

الرقم الطبي : ..... التشخيص: .....

أني قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته و ذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح و مفهوم:

١-سبب الحاجة الى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبًا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبًا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتهابات أو فشل الكبد.

٢-الفوائد المتوقعة من هذا الاجراء

٣-المخاطر و المضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ-ردود الفعل التحسسيةو التي قد تشمل قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب-ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بامراض فيروسية و بكتيرية.

د-مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ-حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم ان وجدت.

٥- حقي في طرح الأسئلة و الحصول على الاجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

اقر انا المقع ادناه باني على كامل المعرفة و الفهم لكل مشتملات هذا الاقرار و اتحمل المسؤلية كاملة عن كل ما فيه

أسم المريض (او ممثله القانوني): ..... اسم الطبيب المعالج/ الرقم الوظيفي: .....

درجة القرابة: ..... التوقيع: .....

رقم قومي / جواز سفر: ..... التاريخ/ الوقت: .....

التوقيع: .....

اسم الشاهد: .....

التاريخ/ الوقت: .....

رقم قومي / جواز سفر: .....

التوقيع: .....

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no:	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age:
Diagnosis:		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion:	☐ No ☐ Yes	
History of Previous Blood Transfusion Reaction:	☐ No ☐ Yes, specify.....	

Number of Units Needed:	**To be delivered to:**
☐ Whole Blood..... Units ☐ Packed Cells..... Units ☐ Platelets.....Units ☐ F.F.P..... Units ☐ Cryoprecipitate..... Units ☐ Auto transfusion..... Units ☐ Other: ..... Units	☐ OR ☐ ED ☐ ICU ☐ BMT
Urgency: ☐ **Immediate**: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing). ☐ **Urgent**: Cross matching tests take **1 hour** ☐ **Routine**: compatibility test take two hours	**Frequency of Transfusion:**

Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date:	Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date:	Time

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

2567	تهاني ثروت نافد
MRN:	1547/24
	نفقة دولة نقدى

Blood Delivery form

	Components	Amount		Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐	Scheduled	
☐	Packed RBCs	One Unit	☐	Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐	High Emergency (withou tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs		☐		
☐	Fresh Frozen Plasma		☐		
☐	Platelet concentrate		☐		
☐	Cryo precipitate		☐		
☐	Irradiated Platelet		☐		

Time of Delivery of Blood Components: 6:25:26 م

Blood Group: (B) RH Group (D antigen): Positive

Antibody Screening: ----------

Cross Matching: Matched

Bag No.:

2724	23944933		
Donation time	EXPIRATION DATE	Donation time	EXPIRATION DATE
25/8/2026	29/9/2026		

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	5-2026-سبتمبر	6:25 م

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
		5-2026-سبتمبر	6:25 م

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

الرقم الطبي:	9593
اسم المريض:	نهاني نبوت ناصف محمد
تاريخ الميلاد:	19/04/1972
رقم الطبي الموحد:	1547/2024

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: ../../.. Time of delivery: 3:12 Transfusion start time: 3:37 End Time: ... : ...

Blood Group & RH Type: B+ Type of blood unit: B+ Blood unit No: .....

Blood unit double checking:	☑ Assigned nurse	Name & ID: Mohiva suid 3059 Signature: Mohiva suid	☑ Charge Nurse	Name & ID: Azza Sedky Signature: Azza Sedky
Patient Identification double checking (bedside):	☐ Assigned nurse	Name & ID: Mohiva suid 3059 Signature: Mohiva suid	☐ Charge Nurse	Name & ID: Azza Sedky Signature: Azza Sedky

Nursing Observation: ☐ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)

If reaction, Notified to: .....Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	3:37	36	98	98	20	110/70	0
After 5 minutes	3:42	36	98	98	20	110/70	0
After 10 minutes	3:47	36	97	99	20	110/70	0
After 15 minutes	3:52	36,5	97	98	17	110/78	0
After 30 minutes	4:17	36,1	98	97	17	110/70	0
After 45 minutes	4:45	36,2	97	98	17	110/70	0
After 60 minutes	5:00	36,2	98	97	17	115/70	0
After 90 minutes	5:30	36,2	98	97	17	110/70	0
After completion of transfusion	-	-	-	-	-	-	-
After 5 minutes from completion of transfusion	5:35	36,5	98	97	17	115/70	0
After 1 hour from completion of transfusion	6:00	36,2	98	97	17	110/70	0
After 2 hours from completion of transfusion	8:00	36,2	98	97	17	115/70	0

Nurse Name & ID: Mohiva Suid 3059 Signature: Mohiva Date: 19/10/2026 Time: .....: .....

* Use separate form for each unit transfused.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

Patient name:	تهاني ثروت ناشد
MRN:	1547/24
نفقة دولة نقدى	

Blood Delivery form

	Components	Amount		Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐	Scheduled	
☐	Packed RBCs	One Unit	☐	Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐	High Emergency (withou tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs		☐		
	Irradiated ad filtered Packed RBCs				
	Washed Packed RBCs				
☐	Platelet concentrate		☐		
☐	Fresh Frozen Plasma		☐		
☐	Cryo precipitate		☐		
☐	Irradiated Platelet		☐		

Time of Delivery of Blood Components: 3:22:49 م

Blood Group bag: B+ Blood Group patient: B+

Cross Matching: Matched Antibody Screening:

Bag No.:	Line No.	Donation time	EXPIRATION DATE
3186	A25039205392	6/10/2026	10/11/2026

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery		Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	10-2026-أكتوبر	3:22 م	

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant	Signature	Date of Delivery		Time
		10-2026-أكتوبر	3:22 م	